

Ética

Dr. Andréé Salvatierra

Iatrogenia

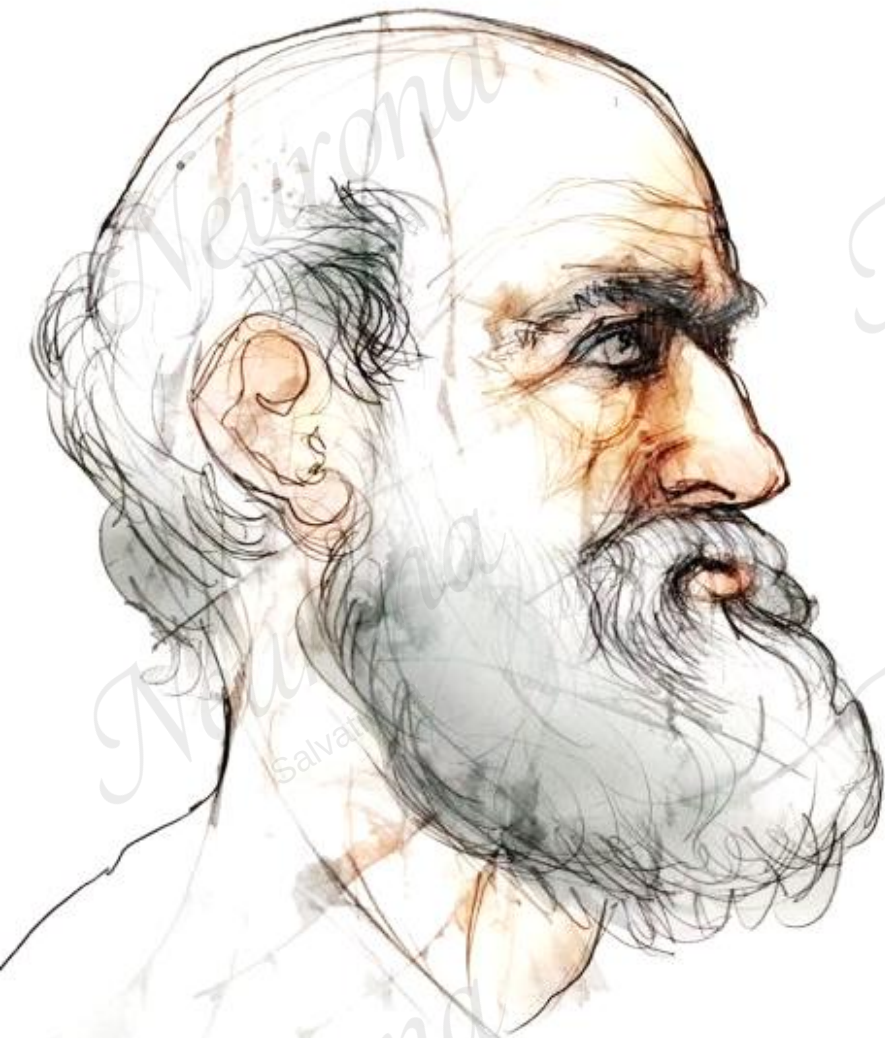


El neologismo se construye
con los términos griegos:

- ☐ «iatros» (médico)
- ☐ «genus» (generado)

Daño en la salud generado por un profesional sanitario,
independientemente si es casual o intencionado (maleficencia)

Se hace un daño al paciente independientemente de la causa



«Primum non nocere»

Lo primero es no hacer daño

Responsabilidad

- ☐ Construye
- ☐ Empodera
- ☐ Óptica al futuro
- ☐ Libera
- ☐ Enfoca
- ☐ Positivo

≠

Culpa

- ☐ Autodestruye
- ☐ Victimiza
- ☐ Óptica al pasado
- ☐ Aprisiona
- ☐ Desorienta
- ☐ Negatividad

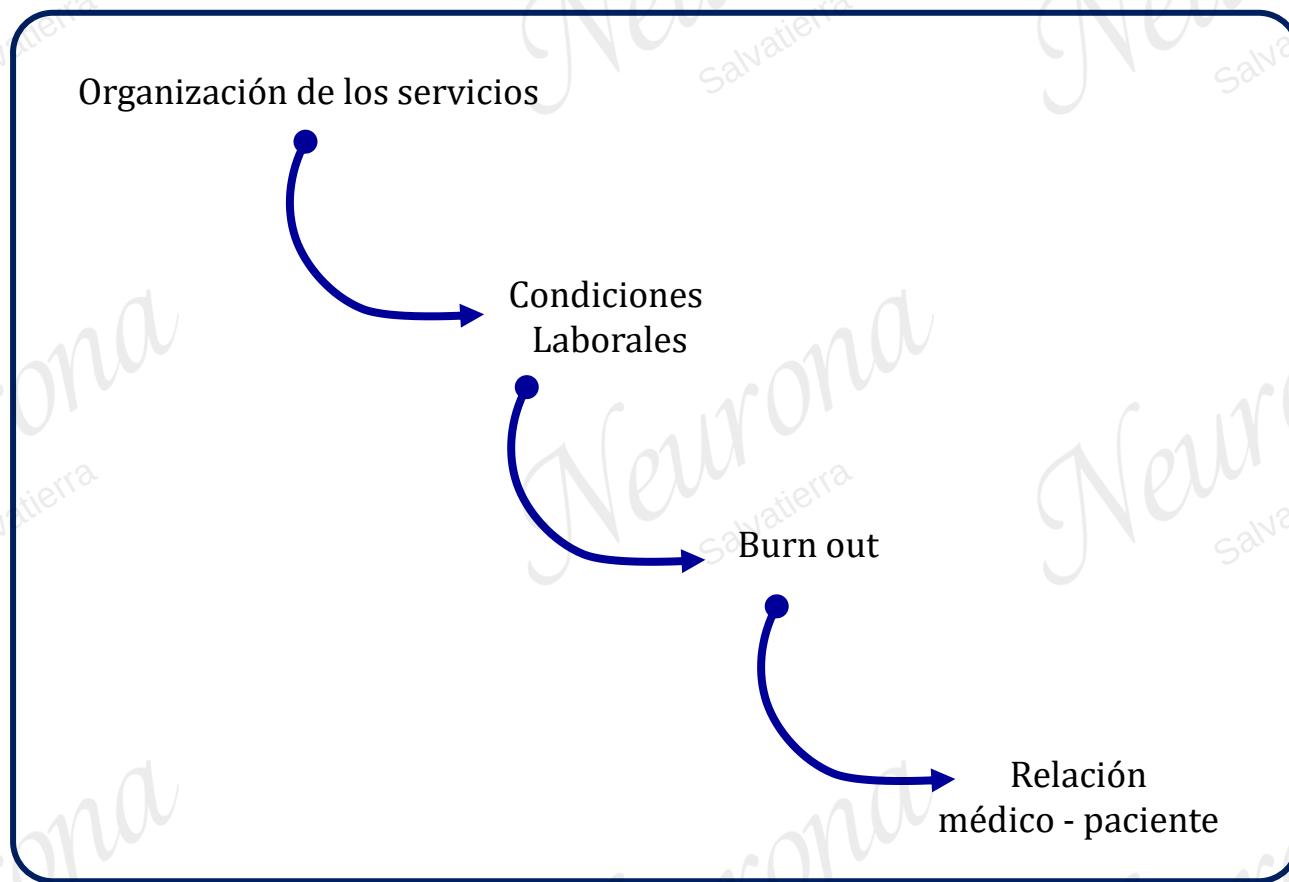
Consentimiento Informado

Facilita la autonomía del paciente (decisión), NO traspasa las responsabilidades



El error es humano, pero NO impune

Factores



Víctimas

Pacientes

Médico

Institución médica

Sociedad

Existen víctimas clínicas y víctimas sociales



IATROGENIA

Antes

Sobrepresión
(medicina defensiva)
(falsos positivos)

Después

Consecuencias de la
acción/ omisión del
profesional sanitario

Durante

En el proceso de
intervención/tratamiento

Causas

Por acción

Las acciones imprudentes, precipitadas e irracionales pueden conducir a daño grave del enfermo.

Por omisión

Al no explorar adecuadamente, no realizar un diagnóstico oportuno y por tanto la ausencia de terapéutica necesaria.

Diagnóstico

Producto de una escasa semiología y una exploración médica superficial, que puede terminar en un diagnóstico erróneo y desencadenando un tratamiento equivocado

Farmacológico

Prescripción inadecuada de medicamento(s)

Reactiva

Debido a una serie de eventos ligados unos a otros que llevan implícita una acción iatropatogénica.



Ignorancia

Desconocimiento de algo que podrías saber

No «deber» porque como humanos no podemos conocerlo todo

Incerteza

Nadie conoce lo suficiente del fenómeno

Error médico

Diagnóstico

Equivocado

Terapéutico

Medicamento mal indicado

Prevención

No aplicar medidas preventivas o excederse con ellas

Comunicación médica

Comunicación con el paciente, familiares y agentes intrahospitalarios

Mala praxis

Al hablar de mala practica clínica esta se puede producir por tres vías:

Imprudencia

Realizar un acto con ligereza, sin las adecuadas precauciones; es decir, es la carencia de templanza o moderación

Impericia

Falta total o parcial, de conocimientos técnicos, experiencia o habilidad en el ejercicio clínico

Negligencia

Descuido del actuar, por acción/omisión del profesional que se desvía de los estándares aceptados en su colectivo, desencadenando una lesión al paciente

¿Por qué hay tanto errores médicos?

- ☐ Errar es humano
- ☐ Complejidad de la actividad médica
- ☐ Escasa cultura de protocolización
- ☐ Escasa cultura de seguridad el paciente
- ☐ Mantenimiento del paternalismo médico

Obstáculos

- ☐ Cuesta aceptar el error (estigma la idea de fracaso)
- ☐ Cultura de ocultación del error
- ☐ Falta de cultura preventiva

¿Cómo tramitar los errores?

- ☐ Notificar
- ☐ Analizar
- ☐ Recolectar información (¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?)
- ☐ Aportar recursos
- ☐ Reunión de trabajo
- ☐ Sistematizar

Sistematizar → protocolo de forma continua y no mecánica, bajo un compromiso profesional y una óptica de criterio

¿Cuál son los errores más comunes?

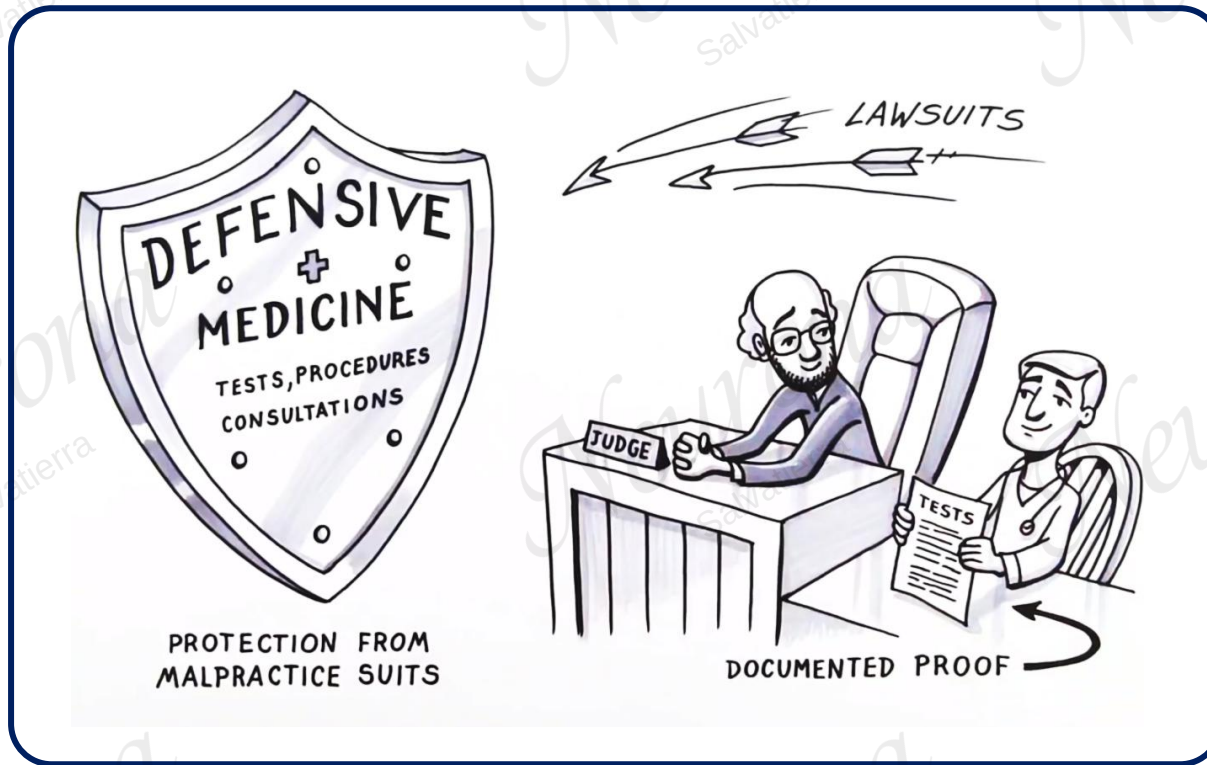
- ☐ Cirugías → ¿derecha del paciente? ó ¿derecha del médico?
- ☐ Equivocación de nombres → A. Aranda / A. Arana
- ☐ Equivocación de medicación → Letra incomprensible
- ☐ Ausencia de seguimiento → «Abandono» al paciente, caso y/o tratamiento

Prevención

- ☐ Información completa del paciente (anamnesis, analíticas, etc...)
- ☐ No establecer diagnóstico/tratamiento sin tener todos los datos
- ☐ Si hay dudas, consulta e investiga
- ☐ No tener vergüenza de no saber
 - *Asumir la ignorancia*
 - *Tolerar y gestionar a la incerteza*
- ☐ Emitir recetas electrónicas (más claras de entender)
- ☐ Asegurar ausencia de interacciones y alergias
- ☐ No medicar sin estar conocer las dosis
- ☐ Consultar guías clínicas o Vademécum

Medicina defensiva

Medicina defensiva



Conjunto de prácticas médicas excesivas e innecesarias, realizadas para evitar el riesgo de reclamación/denuncias por mala práctica

Tiene como inconvenientes muy serios: el aumento desorbitado del costo de la medicina y la pérdida de la confianza mutua entre médico y paciente.

Tipos

Activa

Solicitar



- Derivaciones no justificadas
- Estudios no indicados
- Seguimientos no justificados

Pasiva

Evitar



- Evitar procedimientos de riesgo
- Evitar pacientes de riesgo

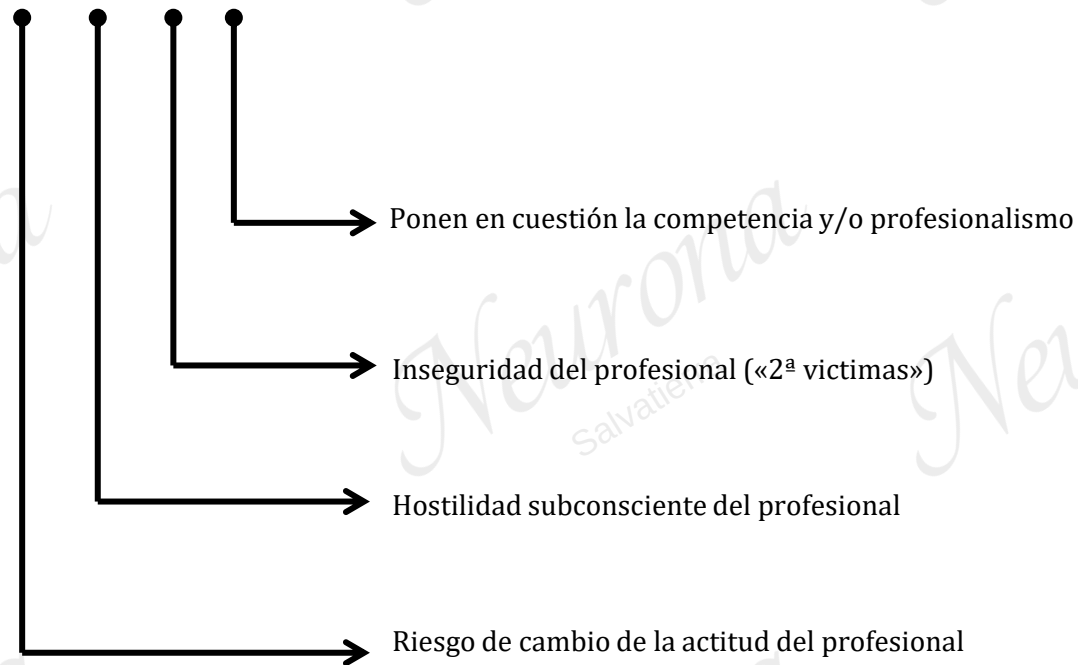
Considerar

- ☐ Papel paternalista del médico
- ☐ Pérdida de confianza médico - paciente
- ☐ Alta expectativa en la medicina actual (*no se espera equivocaciones*)

Paternalismo médico

Modo de llevar la relación del médico con su paciente en que todo el peso de las decisiones lo lleva el médico (modo clásico de ejercer la medicina). Se debe procurar una toma de decisiones cooperativa/compartida entre médico - paciente

Reclamaciones



Consentimiento informado

Facilita la autonomía del paciente (decisión), NO traspasa las responsabilidades

EXCEPCIÓN: «Cuando la no intervención suponga un riesgo para la salud pública y en caso de urgencia vital sin posibilidad de consultar al paciente o familiares»

El error es humano, pero NO impune

Considerar:

Eximentes

Exonera de responsabilidad penal

Atenuantes

Reduce la responsabilidad penal

Agravantes

Aumenta el grado de responsabilidad penal

¿Por qué hay reclamaciones?

- ☐ Mala relación médico - paciente
- ☐ Mala práctica
- ☐ Poca habilidad del profesional en dar explicaciones
- ☐ Los pacientes esperan disculpas del médico

¿La medicina defensiva no es buena?

- ☐ No se basa en pruebas científicas (+ temor a la presencia de reclamos)
- ☐ Alto costo económico y malversación
- ☐ Implica un número de visitas más elevados (+ camas ocupadas)
- ☐ No logra reducir el riesgo
- ☐ Aumenta el número de falsos positivos

Buena medicina

Científica

Empática

Buen sistema sanidad

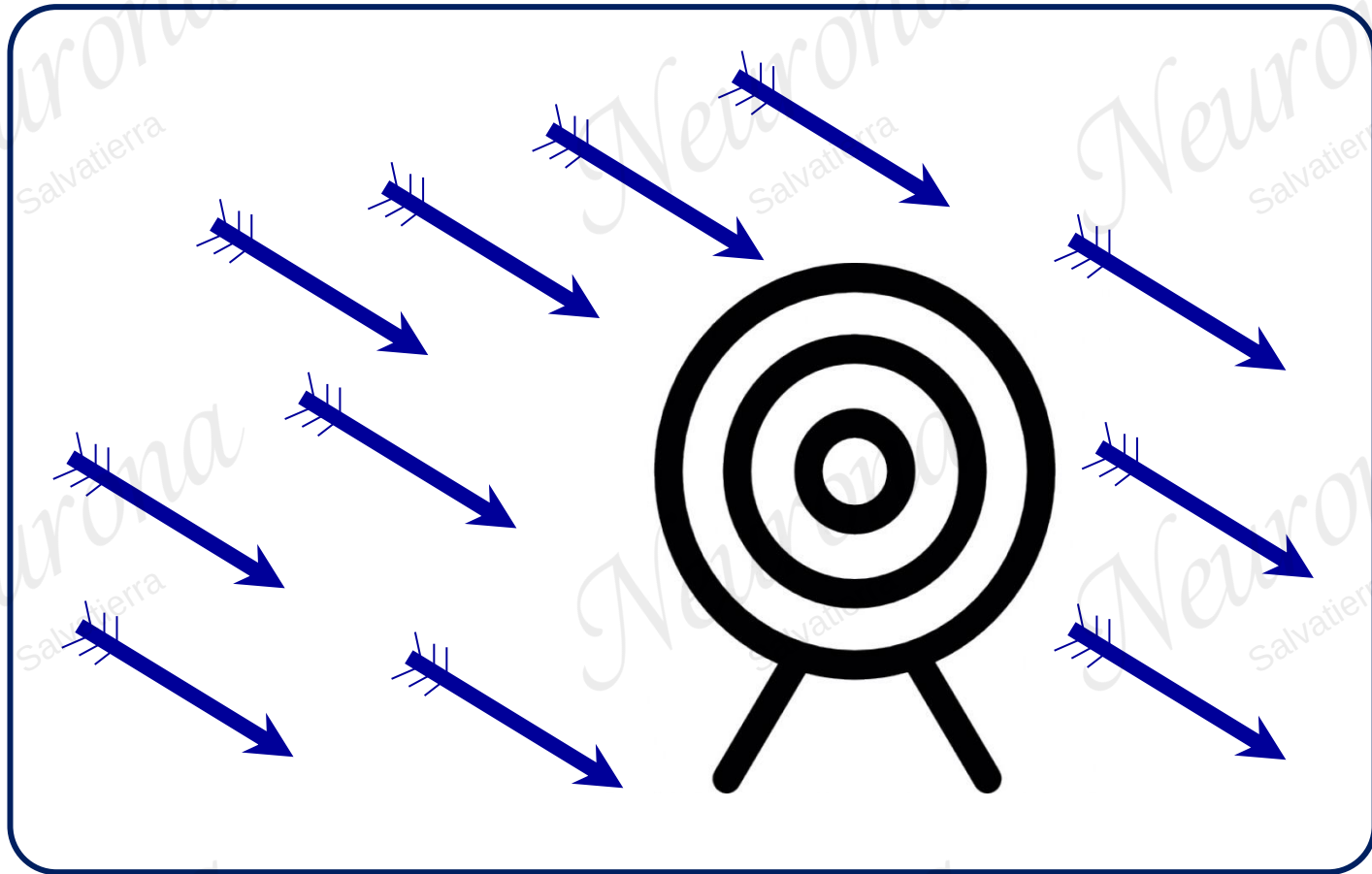
No solicita/realiza actos innecesarios

Medicina prudente/parsimoniosa



Procura prescindir de las prácticas que tienen muy poca utilidad.

No pretende restringir los servicios, sino evitar intervenciones innecesarias, minimizando el daño al paciente ya la vez los gastos



La medicina defensiva tiene más inconvenientes: económicos, no reduce el riesgo, ni mucho menos las reclamaciones

«No es un acto de buena fe sino de inseguridad del profesional»

Prioriza la seguridad del profesional antes que la del paciente

¿Y los pacientes...?

Los pacientes configuran un rol importante; muchos de ellos exageran sus patologías benignas.
Muchas veces son los que exigen estudios innecesarios





Urgencia

Situación de salud que requiere de atención médica pero que **NO** pone en riesgo tu vida.

Emergencia

Situación de salud que **SÍ** pone en riesgo tu vida y que requiere de atención médica inmediata.



Clasificación de paciente según estado de gravedad

C1

**EMERGENCIA
VITAL**



**Atención
inmediata**

C2

**EMERGENCIA
EVIDENTE**



**Paciente
inestable**

C3

URGENCIA



Mediano riesgo

C4

**URGENCIA
LEVE**



**También puede
acudir al SAPU**

C5

**CONSULTA
GENERAL**



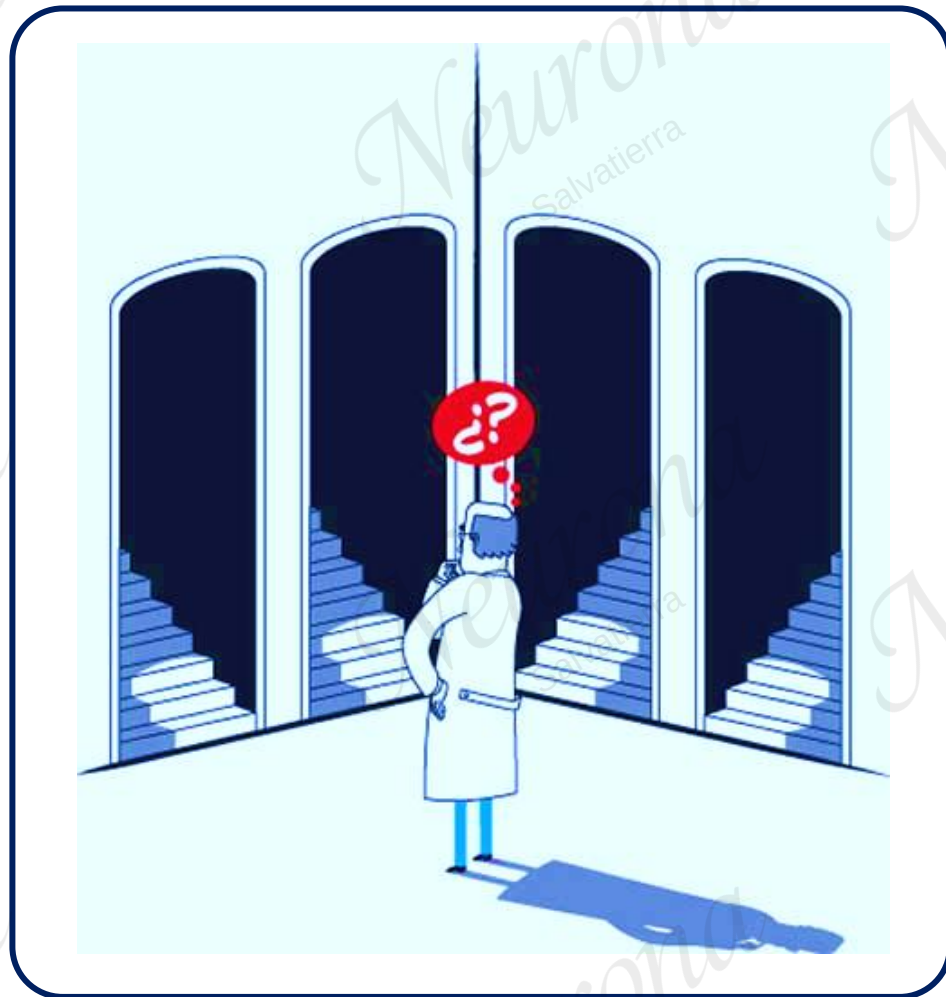
**También puede
acudir al
Consultorio**



Solución



Educación sanitaria



Asumir éticamente la ignorancia del ejercicio y gestionar la incerteza con prudencia